

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

Inventario Corto de Ansiedad por la Salud (SHAI)

Eje I • Versión de trabajo: 9 de agosto de 2026 • Estado: ficha documental, no manual

1 Identificación

Nombre	Inventario Corto de Ansiedad por la Salud
Sigla	SHAI
Autores	Salkovskis, P. M., Rimes, K. A., Warwick, H. M., & Clark, D. M.
Año	2002
Eje	EJE I – PROBLEMAS, SÍNTOMAS Y RIESGO
Constructo principal	Somatización y ansiedad por la salud
Población	Adultos
Tipo de instrumento	Cuestionario de autoinforme
Disponibilidad en español	Sí (Fernández et al., 2014)
Acceso/licencia	Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
Nota curatorial de derechos	Licencia CC BY-NC-ND; no crear derivados.

2 Fundamentación conceptual

Constructo evaluado: Somatización y ansiedad por la salud. La descripción procede del catálogo maestro y debe contrastarse con la fuente original antes de emplearla para decisiones clínicas o de investigación.

Dominio conceptual	Problemas, Síntomas y Riesgo (General)
Dimensiones declaradas	2 factores principales (Preocupación general por la enfermedad, Consecuencias negativas anticipadas de estar enfermo).

3 Características generales

Formato	Cuestionario de autoinforme
Población objetivo	Adultos
Número de ítems	Forma española validada: 18 ítems. Activo local: 14 reactivos; no cumple identidad de versión y queda no apto.
Versión/cantidad curada	No fijado en el ledger estructurado.
Formato de respuesta	Selección múltiple progresiva (4 oraciones descriptivas por ítem, puntuadas de 0 a 3).
Administración	No verificado en una fuente primaria dentro de la biblioteca; consultar manual o protocolo oficial.
Tiempo estimado	No verificado en las fuentes disponibles.

4 Estructura

Dimensiones/subescalas	2 factores principales (Preocupación general por la enfermedad, Consecuencias negativas anticipadas de estar enfermo).
Ítems	18 ítems.
Control curatorial de versión	Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.
Respuesta	Selección múltiple progresiva (4 oraciones descriptivas por ítem, puntuadas de 0 a 3).
Relación ítem-dimensión	No verificada de forma exhaustiva; no reconstruirla sin manual o publicación primaria.
Ítems invertidos	No verificado en las fuentes disponibles.

5 Sistema de puntuación

Sumatoria (0 a 54).

Regla de corrección	Sumatoria (0 a 54).
Ítems invertidos	No verificado en las fuentes disponibles.
Baremos	No verificado en una fuente normativa autorizada.
Control de versión	No aplicar reglas de otra edición, forma breve, traducción o población.

6 Interpretación

Punto de corte ≥ 18 indica probable Trastorno de Ansiedad por la Enfermedad (alta sensibilidad).

Los puntos de corte y baremos deben confirmarse en la versión, población y país pertinentes. No se recomienda transformar estas notas en diagnóstico ni usar cifras no verificadas.

7 Evidencia psicométrica

Sensible a los síntomas nucleares de la ansiedad por la salud sin verse afectada por la enfermedad médica real.

Consistencia interna	No desagregada en el catálogo; consultar los estudios citados.
Validez	Sensible a los síntomas nucleares de la ansiedad por la salud sin verse afectada por la enfermedad médica real.
Fiabilidad temporal	No verificado en las fuentes disponibles.
Muestra y contexto	No verificado de forma suficiente para generalización.

8 Adaptaciones

Español	Sí (Fernández et al., 2014)
Versión/cantidad curada	No fijado en el ledger estructurado.
Versión exacta	Ledger curado disponible con 2 enlace(s); comprobar versión y permiso antes de aplicar.
Población/país	Adultos
Alerta de versión	Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.
Advertencia	Una traducción, forma breve o revisión no es intercambiable con la edición original sin evidencia de equivalencia.

9 Aplicaciones

- Evaluación del constructo Somatización y ansiedad por la salud en Adultos, condicionada a la validez de la versión seleccionada.
- Uso docente o de investigación únicamente cuando lo permitan la licencia, el consentimiento y la cualificación del usuario.
- Uso clínico solo como parte de una evaluación multimétodo; no reemplaza entrevista, juicio profesional ni análisis de riesgo.

10 Fortalezas

- El catálogo identifica autores, año y constructo: Salkovskis, P. M., Rimes, K. A., Warwick, H. M., & Clark, D. M.; 2002.
- Disponibilidad española reportada: Sí (Fernández et al., 2014)
- Trazabilidad local: 1 archivo(s) técnicamente legible(s) y 0 PDF web verificado(s).

11 Limitaciones

- Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
- Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.
- Archivos locales aislados por formato inválido: 0.
- Los datos del maestro pueden contener referencias, versiones o puntos de corte preliminares; prevalece la fuente primaria.
- No se incluyen ítems, instrucciones, claves o baremos cuando su reproducción no está autorizada o no pudo verificarse.

12 Consideraciones éticas

- Obtener consentimiento informado, proteger la confidencialidad y limitar el acceso a resultados.
- Usar profesionales con formación suficiente y documentar versión, idioma, población, fecha y condiciones de administración.
- No emplear la escala como único fundamento de diagnóstico, exclusión, selección o intervención.
- Respetar derechos de autor, licencias, restricciones territoriales y prohibiciones de modificación o redistribución.
- Ante riesgo agudo o hallazgos críticos, seguir protocolos clínicos y legales aplicables; la ficha no sustituye procedimientos de seguridad.

13 Síntesis técnica

Constructo	Somatización y ansiedad por la salud
Población	Adultos
Estructura	Catálogo: 18 ítems.; 2 factores principales (Preocupación general por la enfermedad, Consecuencias negativas anticipadas de estar enfermo).. Control curado: No fijado en el ledger estructurado.
Puntuación	Sumatoria (0 a 54).
Interpretación	Punto de corte ≥ 18 indica probable Trastorno de Ansiedad por la Enfermedad (alta sensibilidad).
Estado de fuentes	Locales válidos: 1; web PDF: 0; aislados: 0.
Estado de uso	Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
Decisión técnica	Ficha documental disponible. La aptitud clínica requiere protocolo autorizado, versión fijada y verificación por profesional competente.

14 Referencias APA 7

Salkovskis, P. M., Rimes, K. A., Warwick, H. M., & Clark, D. M. (2002). Inventario Corto de Ansiedad por la Salud.

Fuente de referencia del catálogo: Artículos científicos.

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6732766/>

<https://roderic.uv.es/rest/api/core/bitstreams/1b9d0759-4a20-42a6-b9c3-60c098c1dac1/content>

Nota de control: las URLs se conservan para trazabilidad; cada publicación mantiene sus propios derechos y condiciones de uso.

Verificación técnica y trazabilidad — revisión 2026-08-10

Esta sección prevalece sobre datos anteriores cuando existe conflicto. Se cotejó el activo local y se usaron únicamente fuentes identificables. 'No verificado' significa que no se encontró evidencia suficiente; no es una inferencia ni una reconstrucción.

1. Versión exacta y activo cotejado	INCOMPATIBLE: PDF local de 14 reactivos; la forma española validada contiene 18 (14 probabilidad + 4 consecuencias). Activo cotejado: Protocolo.pdf, SHA-256 26 821be22 921c2d793f251e2426b57 642d1cf5506e3eddbc50e8c97c46 d4668d.
2. Población e informante	Ficha previa: Adultos. Confirmar límites etarios, contexto e informante en el manual de la versión exacta.
3. Administración	No promover como protocolo SHAI español validado.
4. Tiempo de aplicación	NO VERIFICADO: el formulario no informa una duración y no se localizó una fuente primaria específica de esta forma.
5. Estructura e ítems reales	INCOMPATIBLE: PDF local de 14 reactivos; la forma española validada contiene 18 (14 probabilidad + 4 consecuencias).
6. Periodo temporal	No verificado.
7. Escala/formato de respuesta	Cuatro afirmaciones por reactivo, 0–3; forma incompleta.
8. Algoritmo de puntuación	NO VERIFICADO PARA USO OPERATIVO. Descripción previa: No verificado. Confirmar con manual/clave de la forma exacta antes de aplicar.
9. Manejo de omisiones	NO VERIFICADO: no se encontró una regla explícita y legítima para datos faltantes de la versión exacta. No imputar ni prorratear sin manual.
10. Psicometría específica español/LatAm	España: N=342 comunitarios +31 clínicos; forma de 18 ítems. El estudio propuso 40,5 en su muestra; no aplicable al PDF local de 14.
11. Baremos, cortes e interpretación	Punto de corte ≥ 18 indica probable Trastorno de Ansiedad por la Enfermedad (alta sensibilidad). Usar solo si coincide con la versión/población citada; no se asume universalidad.
12. Licencia, uso y redistribución	Estado conservador: Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir. No redistribuir/modificar hasta documentar titular y permiso de la versión exacta.
13. Referencias y fuentes verificadas	Morales et al. (2019), validación española del SHAI de 18 ítems, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6732766/ . El PDF local tiene 14 reactivos y no equivale a la forma validada.
14. Decisión de QA	NO APTO: el protocolo local de 14 reactivos no coincide con el SHAI español validado de 18.